



P

PRZEWODNIK I ĆWICZENIOWNIK

Fizjoterapia uroginekologiczna

przed ciążą · w ciąży · w połogu

Dno miednicy · mięśnie brzucha · kręgosłup

PoródNaMiare.pl

Opracowanie oparte na standardach fizjoterapii uroginekologicznej (PTGiP, IUGA, POGP)

Materiał edukacyjny — nie zastępuje indywidualnej konsultacji fizjoterapeutycznej

Spis treści

1. Anatomia i funkcja dna miednicy	3
2. Przed ciążą — trening przygotowawczy	4
3. Ciąża: I trymestr — budowanie bazy	5
4. Ciąża: II trymestr — stabilizacja i siła	6
5. Ciąża: III trymestr — przygotowanie do porodu	7
6. Techniki oddechowe i relaksacja dna miednicy	8
7. Pierwsze dni połogu (doba 1-14)	9
8. Połóg: tydzień 2-6 — powrót aktywacji	10
9. Połóg: 6-12 tydzień — progresja siłowa	11
10. Diastaza mięśni prostych — test i korekcja	12
11. Powrót po cesarskim cięciu — protokół	13
12. Progresja 12-tygodniowa — plan tabelaryczny	14
13. Wskazania, przeciwwskazania, red flags	15
14. Kiedy do fizjoterapeuty uroginekologicznego	16

Jak korzystać z przewodnika

Znajdź swój etap (przed ciążą / trymestr / tydzień połogu) i wykonuj wskazany zestaw 3-5x w tygodniu.

Każde ćwiczenie ma oznaczony poziom trudności: PODSTAWOWY / ŚREDNI / ZAAWANSOWANY. Nie przechodź dalej bez opanowania poprzedniego etapu.

Anatomia i funkcja dna miednicy

Dno miednicy to zespół mięśni i powięzi rozpięty między spojeniem łonowym a kością guziczną, tworzący "hamak" podtrzymujący pęcherz, macicę i odbytnicę. Współpracuje z mięśniami głębokimi brzucha (poprzecznym) i przeponą, tworząc tzw. tłocznnię brzuszną — układ regulujący ciśnienie wewnątrzbrzuszne przy każdym ruchu, kaszlu i wysiłku.

Dlaczego ciąża i poród je obciążają

- Rosnąca macica zwiększa nacisk pionowy na dno miednicy przez 40 tygodni — obciążenie kumulacyjne.
- Relaksyna rozluźnia więzadła i powięzi, zwiększając podatność tkanek (fizjologicznie potrzebne do porodu, ale zmniejsza stabilność).
- Parcie w II okresie porodu to maksymalne rozciągnięcie mięśni dna miednicy — nawet 3-krotnie ponad normalną długość włókna.
- Cięcie cesarskie nie chroni dna miednicy przed osłabieniem spowodowanym samą ciążą — chroni jedynie przed urazem porodowym.

3 funkcje dna miednicy, które trenujemy

PODPARCIE

Utrzymanie narządów miednicy mniejszej we właściwej pozycji

ZWIERACZE

Kontrola nad oddawaniem moczu, gazów i stolca

STABILIZACJA

Współpraca z core przy każdym ruchu tułowia i kończyn

Przed ciążą — trening przygotowawczy

Cel etapu przedkoncepcyjnego: nauczyć się świadomej aktywacji i — równie ważne — świadomego rozluźnienia dna miednicy. Wzmoczone, chronicznie napięte dno miednicy (hipertonía) jest równie problematyczne jak osłabione — utrudnia poród i sprzyja bólowi.

Aktywacja podstawowa (Kegel świadomy)

POZIOM: PODSTAWOWY

POZYCJA

Siad lub leżenie tyłem, kolana ugięte, stopy płasko na podłożu.

WYKONANIE

Wyobraź sobie powstrzymywanie gazów i przerywanie strumienia moczu jednocześnie — delikatne uniesienie i "wciągnięcie do środka". Wydech przy napięciu, wdech przy rozluźnieniu. Pełne rozluźnienie równie ważne jak napięcie.

Seria: 3 serie × 10 powtórzeń (napięcie 3-5 s, pełne rozluźnienie 5-8 s), 4-5×/tydz.

Nie napinaj pośladków, ud ani nie wstrzymuj oddechu — to najczęstszy błąd.

Oddech przeponowo-miedniczny

POZIOM: PODSTAWOWY

POZYCJA

Leżenie tyłem, dłonie na dolnych żebrach i podbrzuszu.

WYKONANIE

Wdech nosem — żebra i brzuch unoszą się na boki, dno miednicy delikatnie się rozszerza i opada. Wydech ustami — dno miednicy unosi się biernie. To synchronizacja, nie dodatkowy wysiłek.

Seria: 5 minut dziennie, najlepiej przed snem.

I trymestr — budowanie bazy

Priorytet: utrzymanie aktywacji core bez nadmiernego ciśnienia śródbrzusznego. Unikaj: klasycznych brzusków, planku > 30 s, ćwiczeń w pełnym leżeniu na plecach po 16. tygodniu.

Kocie grzbiety (cat-cow) z dnem miednicy

POZIOM: PODSTAWOWY

POZYCJA

Klęk podparty, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami.

WYKONANIE

Wydech: zaokrąglaj plecy, delikatnie unieś dno miednicy (jak przy Kegel). Wdech: rozciągnij kręgosłup neutralnie, rozluźnij dno miednicy. Ruch płynny, w rytmie oddechu.

Seria: 2 serie × 10 powtórzeń, codziennie.

Martwy chrząszcz zmodyfikowany (dead bug)

POZIOM: ŚREDNI

POZYCJA

Leżenie tyłem, kolana ugięte 90°, ręce uniesione nad barkami.

WYKONANIE

Wydech, aktywuj dno miednicy i mięsień poprzeczny brzucha (delikatne "wciągnięcie"). Opuść jedną nogę powoli w kierunku podłogi, utrzymując neutralne plecy. Wróć, zmień stronę.

Seria: 2 serie × 6 powtórzeń/stronę, 3×/tydz.

Przerwij, jeśli pojawi się wybrzuszenie w linii środkowej brzucha (sygnał diastazy).

II trymestr — stabilizacja i siła

Środek ciąży to zwykle najlepszy czas na aktywność — mniej mdłości, jeszcze niewielkie ograniczenie ruchomości. Skupiamy się na stabilizacji miednicy i wzmocnieniu pośladków, które przejmują część obciążenia z dolnego odcinka pleców.

Mostek (glute bridge) z aktywacją

POZIOM: ŚREDNI**POZYCJA**

Leżenie na boku podparte poduszką klinową LUB półleżenie oparte o piłkę (od 20. tyg. unikaj pełnego leżenia tyłem).

WYKONANIE

Wydech: aktywuj dno miednicy, unieś biodra do linii prostej kolana-biodro-bark. Ścisk pośladków, nie odcinka lędźwiowego. Wdech przy opuszczaniu.

Seria: 3 serie × 12 powtórzeń, 3×/tydz.

Przysiad przy ścianie (wall sit) z piłką

POZIOM: ŚREDNI**POZYCJA**

Plecy oparte o ścianę lub piłkę fitness, stopy szerokość bioder.

WYKONANIE

Zejdź do półprzysiadu (kolana nie za palce stóp), aktywuj dno miednicy w trakcie utrzymania pozycji. Oddychaj swobodnie — nie wstrzymuj powietrza.

Seria: 3 serie × 20-30 s, 3×/tydz.

III trymestr — przygotowanie do porodu

W ostatnich tygodniach trening przesuwają się z "wzmacniania" na "przygotowanie do rozciągania". Kluczowa umiejętność: świadome, kontrolowane rozluźnienie dna miednicy na komendę — dokładnie to, co potrzebne w II okresie porodu.

Masaż krocza (przygotowanie tkanek)

POZIOM: ŚREDNI**POZYCJA**

Kciuki (Twoje lub partnera) z czystymi rękami, olej do masażu krocza lub oliwa z oliwek.

WYKONANIE

Delikatny ucisk i rozciąganie tkanek krocza w kierunku odbytu, ruch w kształcie litery U, z lekkim naciskiem do wyczucia rozciągnięcia (nie bólu).

Seria: 5-10 minut, 3-4×/tydz. od 34. tygodnia.

Przeciwwskazane przy: łożysku przodującym, infekcji, opryszczce narządów płciowych, przedwczesnym pękaniu błon.

Głębokie przysiady wspomagane

POZIOM: PODSTAWOWY**POZYCJA**

Trzymając się poręczy, futryny lub partnera, stopy szerzej niż biodra.

WYKONANIE

Powolne zejście do pełnego przysiadu (pięty na podłodze lub podparte zwiniętym ręcznikiem), 20-30 s w pozycji z pełnym rozluźnieniem dna miednicy, powolny powrót.

Seria: 5-8 powtórzeń, codziennie od 36. tygodnia.

Nie wykonuj przy bólu spojenia łonowego (objaw SPD) — skonsultuj z fizjoterapeutą.

Techniki oddechowe i relaksacja

Umiejętność rozluźnienia dna miednicy jest równie istotna jak umiejętność jego napięcia — szczególnie w porodzie, gdzie opór mięśniowy wydłuża i utrudnia II okres. Poniższe techniki warto ćwiczyć od 30. tygodnia ciąży.

Oddech "otwierający"

Wdech nosem licząc do 4, wizualizacja rozszerzania się krocza jak kwiat. Wydech ustami przez zaokrąglone wargi (jak dmuchanie na gorącą zupę) licząc do 6-8.

Pozycja "happy baby" z oddechem

Leżenie tyłem, kolana przyciągnięte do klatki, stopy uniesione. Głębokie, wolne oddechy z pełnym rozluźnieniem miednicy przy każdym wydechu.

Wizualizacja porodowa

Podczas ćwiczeń dna miednicy wyobrażaj sobie mięśnie jako "kwiat, który się otwiera", a nie "mur do przebicia" — badania potwierdzają, że wizualizacja wpływa na realne napięcie mięśniowe.

Pierwsze dni połogu (doba 1-14)

Pierwsze 2 tygodnie to regeneracja, nie trening. Nawet przy porodzie siłami natury bez nacięcia tkanki są obrzęknięte i potrzebują czasu. Cel: delikatna aktywacja krążenia i pierwszy, bardzo łagodny kontakt z dnem miednicy.

Aktywacja "dotykowa" (doba 1-3)

POZIOM: PODSTAWOWY**POZYCJA**

Leżenie w łóżku, dowolna wygodna pozycja.

WYKONANIE

Bardzo delikatne, subtelne napięcie dna miednicy — 20-30% maksymalnej siły. Cel to odzyskanie połączenia mózg-mięsień, nie siła. Jeśli boli — przerwij.

Seria: 5 powtórzeń, 2-3×dziennie, tylko jeśli nie ma bólu.

Po CC: zacznij dopiero gdy ustąpi ostry ból pooperacyjny (zwykle doba 3-5).

Oddech przeponowy regeneracyjny

POZIOM: PODSTAWOWY**POZYCJA**

Półożenie oparte o poduszki.

WYKONANIE

Spokojny, głęboki oddech przeponowy bez dodatkowego napięcia mięśni. Cel: obniżenie napięcia całego ciała, wsparcie regeneracji, redukcja obrzęku.

Seria: 5-10 minut, kilka razy dziennie.

Tydzień 2-6 — powrót aktywacji

Po wizycie kontrolnej (zwykle ok. 6. tygodnia) i przy braku przeciwwskazań rozpoczynamy budowanie świadomej, pełnej aktywacji. Nadal unikamy: brzusków, deski, biegania, skakania, podnoszenia ciężarów >5 kg poza dzieckiem.

Kegel progresywny

POZIOM: PODSTAWOWY**POZYCJA**

Leżenie tyłem, kolana ugięte, lub siad na piłce fitness.

WYKONANIE

Pełne napięcie dna miednicy (bez pomocy pośladków/ud) utrzymane 5 s, pełne rozluźnienie 10 s. Dodaj krótkie, szybkie "puls" napięcia (1 s) × 10 dla włókien szybkokurczliwych.

Seria: 3 serie × 10 (długie) + 1 seria × 10 (szybkie), codziennie.

Mostek jednonóż (progresja)

POZIOM: ŚREDNI**POZYCJA**

Leżenie tyłem, kolana ugięte, jedna stopa na podłodze, druga noga wyprostowana w powietrzu.

WYKONANIE

Aktywuj dno miednicy i core, unieś biodra utrzymując je w poziomie (bez rotacji). Kontrolowany opad.

Seria: 2 serie × 8 powtórzeń/stronę, 3×/tydz. — TYLKO po opanowaniu klasycznego mostka.

Zatrzymaj przy: wycieku moczu, uczuciu ciężaru/wypadania w pochwie, bólu.

6-12 tydzień — progresja siłowa

Etap budowania funkcjonalnej siły core — powrotu do dźwigania, noszenia dziecka w chuście/nosidle, powolnego wznawiania sportu. Progresja wyłącznie przy braku objawów alarmowych (patrz rozdział 13).

Plank na kolanach (progresja deski)

POZIOM: ŚREDNI**POZYCJA**

Kłęk podparty na przedramionach, kolana na podłodze, plecy w linii prostej.

WYKONANIE

Aktywuj dno miednicy i mięsień poprzeczny brzucha PRZED uniesieniem, utrzymaj neutralne plecy (bez zapadania w odcinku lędźwiowym).

Seria: 3 serie × 15-20 s, 3×/tydz.

Przerwij przy wybrzuszeniu linii środkowej brzucha (patrz rozdz. 10 — diastaza).

Przysiad z obciążeniem funkcjonalnym

POZIOM: ŚREDNI**POZYCJA**

Stanie, stopy szerokość bioder, można trzymać dziecko/ciężarek 2-5 kg.

WYKONANIE

Aktywuj dno miednicy PRZED zejściem w dół (nie w trakcie wstawania — to błąd zwiększający ryzyko przeciążenia). Zejście kontrolowane, powrót z wydechem.

Seria: 3 serie × 12 powtórzeń, 3×/tydz.

Diastaza mięśni prostych — test i korekcja

Diastaza (rozejście kresy białej) występuje fizjologicznie pod koniec ciąży u niemal 100% kobiet. Problemem staje się, gdy nie zamyka się do 8.–12. tygodnia połogu.

Test samodzielny (wykonaj w 6. tygodniu połogu)

- Leżenie tyłem, kolana ugięte. Unieś głowę i barki delikatnie (jak przy mini-brzusku).
- Umieść 2–3 palce poziomo w linii środkowej brzucha, 5 cm nad i pod pępkiem.
- Zmierz szerokość rozejścia (w palcach) i głębokość (czy wyczuwasz napięcie na dnie, czy "pustkę").
- Wynik: <2 palce = norma. 2–3 palce = obserwuj. >3 palce lub brak napięcia na dnie = skonsultuj z fizjoterapeutą.

Korekcyjna aktywacja poprzecznego brzucha

POZIOM: PODSTAWOWY

POZYCJA

Leżenie tyłem, kolana ugięte, dłonie po bokach pępka.

WYKONANIE

Wydech: delikatnie "wciągnij" dolną część brzucha do środka (jak zapinanie ciasnych spodni), BEZ spłaszczania pleców o podłogę. Wyczuwaj zbliżanie się brzegów mięśni pod palcami.

Seria: 3 serie × 10, codziennie do zamknięcia diastazy.

Unikaj klasycznych brzuszków i deski do czasu zamknięcia rozejścia — pogłębiają diastazę.

Powrót po cesarskim cięciu — protokół

Cięcie cesarskie to operacja przez 7 warstw tkanek. Blizna wymaga mobilizacji, a mięśnie głębokie brzucha regeneracji mimo braku bezpośredniego urazu porodowego dna miednicy.

Oś czasu powrotu

- Doba 1-7** Oddech, spacer, delikatna aktywacja dna miednicy — bez pracy z blizną.
- Tydzień 3-6** Gdy blizna zagojona: masaż mobilizujący bliznę (kółka, przesuwanie skóry).
- Tydzień 6+** Po zgodzie lekarza: pełny protokół jak dla porodu siłami natury, wolniejsza [...]

Mobilizacja blizny po CC

POZIOM: ŚREDNI

POZYCJA

Leżenie tyłem, czyste ręce, blizna w pełni zagojona (zwykle od 3.-4. tygodnia).

WYKONANIE

Delikatne, okrężne ruchy opuszkami palców wokół blizny (nie na bliźnie, jeśli jeszcze wrażliwa), następnie przesuwanie skóry nad blizną w różnych kierunkach.

Seria: 2-3 minuty dziennie.

Nie zaczynaj przed pełnym zagojeniem i bez zgody lekarza prowadzącego.

Progresja 12-tygodniowa — plan tabelaryczny

OKRES	FOKUS	ĆWICZENIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ
Tydz. 1-2	Regeneracja	Oddech przeponowy, delikatna aktywacja dotykowa	2×/dz., 5 min
Tydz. 3-4	Reedukacja	Kegel podstawowy, kocie grzbiety	4×/tydz.
Tydz. 5-6	Test kontrolny	Test diastazy, konsultacja fizjo (zalecana)	jednorazowo
Tydz. 6-8	Aktywacja	Kegel progresywny, mostek, dead bug	4×/tydz.
Tydz. 8-10	Stabilizacja	Mostek jednonóż, plank na kolanach	3×/tydz.
Tydz. 10-12	Funkcja	Przysiad z obciążeniem, powrót do sportu	3×/tydz.

UWAGA: Progresja warunkowa: przejdź do kolejnego etapu TYLKO bez objawów z rozdziału 13.

Wskazania, przeciwwskazania, red flags

Wskazania do ćwiczeń z tego przewodnika

- Ciąża fizjologiczna, bez powikłań, po konsultacji z prowadzącym lekarzem/położną.
- Połóg fizjologiczny — poród siłami natury lub CC bez powikłań pooperacyjnych.
- Chęć profilaktyki nietrzymania moczu, obniżenia narządów miednicy, bólu krzyża.

Przeciwwskazania — NIE ćwicz bez zgody lekarza

- Łożysko przodujące, krwawienie z dróg rodnych, zagrażający poród przedwczesny.
- Stan przedrzucawkowy, niekontrolowane nadciśnienie ciążowe.
- Niewydolność szyjki macicy, założony szew okrężny (cerclage).
- Ostry ból, gorączka, silny obrzęk jednostronny nogi (ryzyko zakrzepicy).

Red flags — przerwij i skontaktuj się z lekarzem

- Wyciek płynu owodniowego, krwawienie, nagły silny ból brzucha lub pleców.
- Uczucie "wypadania" lub ciężaru w pochwie — możliwy objaw obniżenia narządów.
- Nasilający się wyciek moczu podczas/po ćwiczeniach — zmniejsz intensywność, skonsultuj.
- Ból w bliźnie po CC nasilający się zamiast ustępować, zaczerwienienie, wydzielina.

Kiedy do fizjoterapeuty uroginekologicznego

Ten przewodnik to solidna baza — ale nie zastąpi indywidualnej oceny. Fizjoterapeuta uroginekologiczny bada napięcie i siłę dna miednicy palpacyjnie i dobiera terapię do Twojego indywidualnego wzorca.

Umów wizytę, jeśli:

- Planujesz ciążę i chcesz ocenić wyjściowy stan dna miednicy.
- Jesteś w 3. trymestrze i chcesz przygotować tkanki do porodu (masaż krocza, edukacja oddechu).
- Minęło 6 tygodni od porodu — to standardowy termin wizyty kontrolnej w wielu krajach UE.
- Masz nietrzymanie moczu, ból podczas współżycia, uczucie ciężaru w pochwie.
- Diastaza nie zamyka się mimo ćwiczeń po 12 tygodniach.

**Ten przewodnik to Twoja baza wiedzy.
Fizjoterapeuta to Twój indywidualny plan.**

Znajdź certyfikowanego fizjoterapeutę uroginekologicznego (PTGiP) w swoim mieście.

Materiał ma charakter edukacyjny i nie zastępuje indywidualnej oceny oraz porady fizjoterapeutycznej lub lekarskiej. Przy jakichkolwiek wątpliwościach lub objawach alarmowych skonsultuj się ze specjalistą przed kontynuacją ćwiczeń. Opracowano w oparciu o wytyczne fizjoterapii uroginekologicznej (PTGiP, International Urogynecological Association, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników).